



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PROGRAM KERJA KOMITE PPI
TAHUN 2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI2

BAB I3

PENDAHULUAN.....3

1.1 Latar Belakang3

1.2 Dasar Hukum3

1.3 Tujuan.....4

BAB II6

GAMBARAN UMUM6

2.1 Visi6

2.2 Misi6

2.3 Motto.....6

2.4 Landasan 7 Nilai Budi Utama6

2.5 SOTK.....7

BAB III9

KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN.....9

3.1 Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan9

3.2 Sasaran18

3.3 Cara Melaksanakan Kegiatan.....25

3.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 202628

3.5 Kebutuhan Anggaran33

BAB IV.....38

MONITORING DAN EVALUASI.....38

8.1 Monitoring.....38

8.2 Evaluasi38

BAB V.....39

PENCATATAN DAN PELAPORAN.....39

BAB VI.....40

PENUTUP.....40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, tindakan medik yang dilaksanakan selama 24 jam melalui upaya kesehatan perorangan. Dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit, maka rumah sakit harus melakukan upaya peningkatan mutu dan pelayanan medic baik melalui akreditasi, sertifikasi, ataupun proses peningkatan mutu lainnya.

Dalam perkembangannya pelayanan rumah sakit tidak terlepas dari pembangunan ekonomi masyarakat. Perkembangan ini tercermin pada perubahan fungsi klasik RS yang pada awalnya hanya memberi pelayanan yang bersifat penyembuhan (kuratif) terhadap pasien. Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan pendapatan dan pendidikan masyarakat, rumah sakit pun semakin meningkatkan pelayanannya. Pelayanan rumah sakit saat ini tidak hanya bersifat kuratif (penyembuhan) tetapi juga bersifat rehabilitatif (pemulihan) yang dilaksanakan secara terpadu melalui upaya promosi kesehatan (promotif) dan pencegahan (preventif).

HAIs adalah infeksi yang terjadi pada pasien dimana pada waktu dirumah belum terjadi proses infeksi dan baru muncul saat dilakukan perawatan di Rumah sakit atau infeksi yang terjadi pada tenaga kesehatan. Infeksi Rumah Sakit (IRS) atau HAIs (*Health-care Associated infections*) merupakan masalah serius yang harus dicegah dan dikendalikan sebaik-baiknya. Angka kejadian HAIs terus meningkat antara 1-40% yang berdampak pada peningkatan lama rawat (LOS), biaya perawatan dan resiko morbiditas dan mortalitas. Angka kejadian HAIs meningkat sampai 40% di Asia, Amerika Latin dan Afrika. Oleh karena itu *World Health Organization* (WHO) melalui gerakan *global patient safety challenge* menekankan pentingnya program pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI). Komite PPI adalah komite yang bertugas untuk mencegah terjadinya Hais di Rumah sakit.

Kejadian infeksi ini dapat menghambat proses penyembuhan dan pemulihan pasien bahkan dapat menimbulkan peningkatan morbiditas, mortalitas, dan memperpanjang lama hari rawat, sehingga biaya meningkat dan akhirnya mutu pelayanan di sarana kesehatan akan menurun. Tak dipungkiri lagi untuk masa yang akan datang dapat timbul tuntutan hukum bagi sarana pelayanan kesehatan.

Oleh karena hal tersebut diatas sudah saatnya semua sarana pelayanan kesehatan dimana saja, kapan saja dan kepada siapa saja pelayanan kesehatan diberikan harus melaksanakan program pencegahan dan pengendalian infeksi.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di Fasyankes;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Fasyankes;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;

1.3 Tujuan

1. Tujuan Umum
Meningkatkan mutu layanan rumah sakit dan menurunkan resiko infeksi terkait pelayanan di rumah sakit melalui program pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit.
2. Tujuan Khusus
Tercapainya pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit melalui:
 - a. Peningkatan kegiatan surveilans
Surveilans HAI's
 - 1.1 Indikator IDO $\leq 2\%$
 - 1.2 Indikator VAP $\leq 5,8\%$
 - 1.3 Indikator IADP $\leq 3,5\%$
 - 1.4 Indikator ISK $\leq 4,7\%$Surveilans mutu pelayanan keperawatan
 - 1.5 Indikator Phlebitis $\leq 5\%$
 - 1.6 Indikator Decubitus 0%
 - b. Penerapan bundles HAI's di rumah sakit.
 - c. Peningkatan pelaksanaan kewaspadaan standar dan transmisi:
 - 2.1 Pengkajian risiko infeksi (Assesmen berkala terhadap resiko infeksi), menetapkan sasaran penurunan risiko infeksi, dan mengukur serta me-review risiko infeksi (ICRA).
 - 2.2 Pelaksanaan kebersihan tangan mencapai $>85\%$.
 - 2.3 Pelaksanaan kebersihan pernapasan dan etika batuk dilakukan dengan benar.
 - 2.4 Kesesuaian proses penempatan pasien.
 - 2.5 Pelaksanaan penggunaan APD sesuai dengan jenis transmisi penyakit dan jenis tindakan yang dilakukan.
 - 2.6 Monitoring proses pelaksanaan Teknik aseptik pada saat melakukan pelayanan.
 - 2.7 Monitoring praktek penyuntikan yang aman dan pencegahan cedera karena benda tajam serta perlindungan karyawan.
 - 2.8 Monitoring kebersihan lingkungan.
 - 2.9 Monitoring pengelolaan linen di unit maupun laundry.
 - 2.10 Monitoring pengelolaan limbah infeksius dan benda tajam.
 - 2.11 Monitoring dekontaminasi dan pemrosesan ulang peralatan pasien yang dapat digunakan kembali.
 - 2.12 Monitoring kegiatan pelayanan makanan.
 - 2.13 Monitoring pelaksanaan kewaspadaan kontak.
 - 2.14 Monitoring pelaksanaan kewaspadaan droplet.
 - 2.15 Monitoring pelaksanaan kewaspadaan airborne.
 - 2.16 Monitoring kegiatan permesinan.
 - 2.17 Monitoring kegiatan pembongkaran, Pembangunan dan renovasi.
 - 2.18 Melakukan investigasi wabah (outbreak) penyakit infeksi.
 - d. Pendidikan dan pelatihan petugas.
 - e. Meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan antimikroba secara aman.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Visi

Rumah Sakit Prima Husada memiliki visi :

“ Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat.”

2.2 Misi

Rumah Sakit Prima Husada memiliki misi :

1. Memberikan pelayanan Kesehatan dengan aman, tepat, cepat, dan akurat.
2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien.
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan.

2.3 Motto

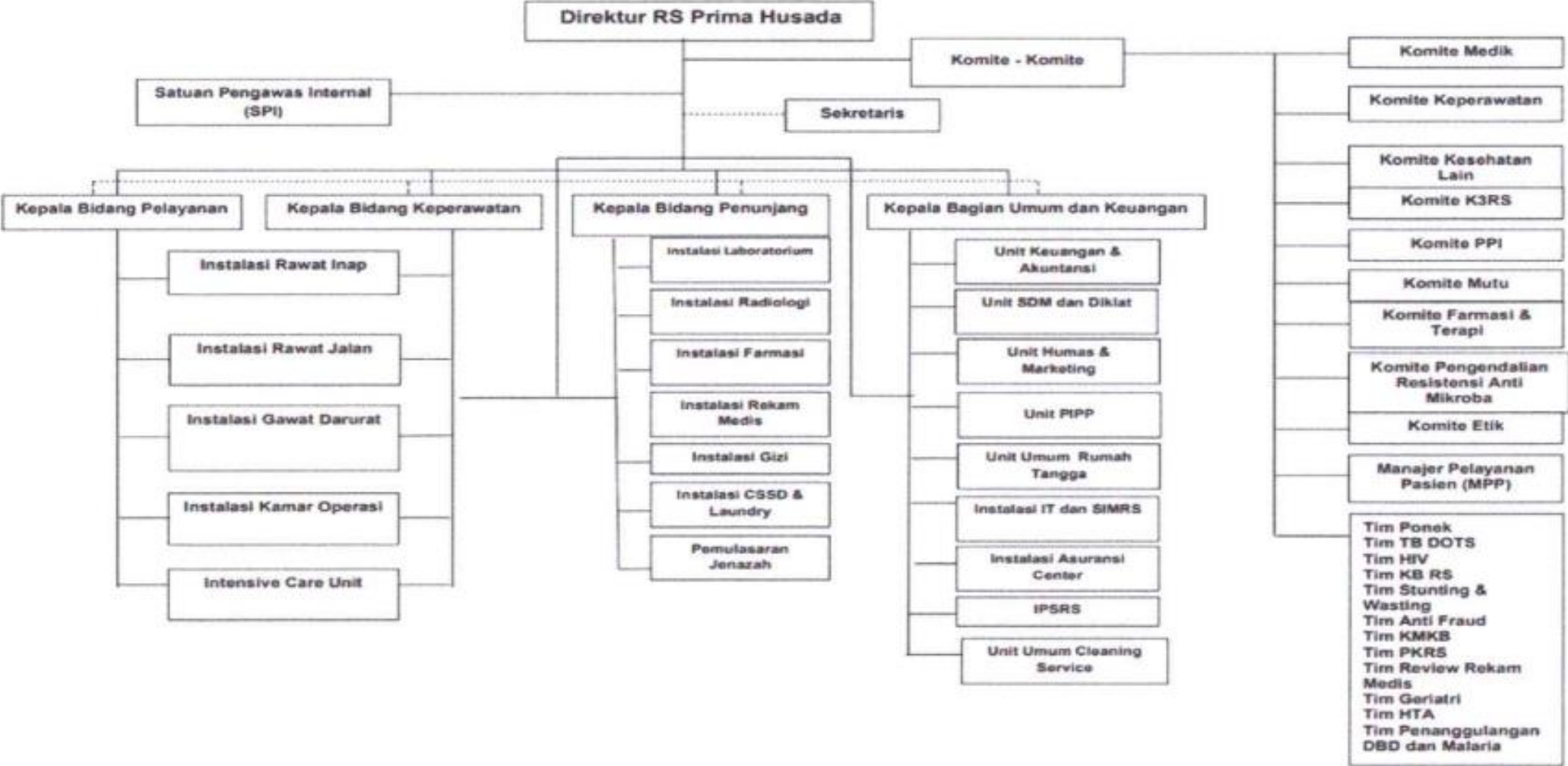
“Sahabat Menuju Sehat”

2.4 Landasan 7 Nilai Budi Utama

Rumah Sakit Prima Husada memiliki Landasan 7 Nilai Budi Utama :

1. Jujur dan dipercaya
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 SOTK



SUSUNAN KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI
RS PRIMA HUSADA

Direktur RS Prima Husada

Ketua Komite PPI (IPCO)

Sekretaris (IPCN)

IPCLN & ANGGOTA PPI

BAB III

KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

3.1 Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

Tabel 3.1 Kegiatan pokok dan rincian kegiatan Komite PPI 2026

No	PROGRAM POKOK	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1	SDM Komite PPI	Kebutuhan SDM	• Sesuai dengan PMK 27 tahun 2017, standar jumlah SDM PPI (IPCN) yaitu 1:100TT, masih mencukupi. • Sudah tersedia IPCO di Komite PPI namun tidak berjalan dengan maksimal, saran untuk menunjuk IPCO baru agar dapat menjalankan tugas dengan maksimal.
2	Surveilans HAI's	Surveillans HAI's: - Surveilans IDO - Surveilans VAP - Surveilans IADP - Surveilans ISK - Surveilans Decubitus - Surveilans Phlebitis	• Menetapkan data surveillans yang dikumpulkan dan metode surveinya • Melakukan sensus harian • Melakukan analisa • Membuat rencana tindak lanjut • Membuat laporan bulanan
3	Kewaspadaan Isolasi	Investigasi dan analisis risiko infeksi dengan program mutu, keselamatan pasien dan keselamatan kerja (Manrisk)	• Mengumpulkan data • Melakukan analisa • Membuat rencana tindak lanjut • Melakukan tindakan perbaikan (Redesign)
		Membuat <i>Infection Risk Assesment</i> (ICRA)	• Mengidentifikasi risiko infeksi • Menganalisa risiko infeksi • Mengevaluasi risiko infeksi • Menyusun langkah-langkah pencegahan dan pengendalian infeksi • Memonitoring pelaksanaan kegiatan, prosedur dan pedoman-pedoman PPI

		Monitoring kepatuhan Hand hygiene dan fasilitas kebersihan tangan.	• Menyusun jadwal • Melakukan Monitoring (oleh IPCN/IPCLN) • Menganalisa hasil monitoring • Membuat rencana tindak lanjut • Membuat laporan • Merevisi SPO kebersihan tangan • Pelatihan & sosialisasi kebersihan tangan ke semua unit. • Melakukan audit kebersihan tangan. • Audit fasilitas kebersihan tangan. • Rekap kepatuhan kebersihan tangan. • Berikan <i>feedback</i> ke unit terkait. • Edukasi kebersihan tangan ke pasien, pengunjung, dan keluarga.
		Monitoring penerapan etika batuk.	• Revisi SPO Etika batuk/bersin • Sosialisasi regulasi Etika batuk/bersin • Audit kepatuhan Etika batuk/bersin • Usulan kelengkapan fasilitas Etika batuk/bersin • Rekap audit kepatuhan • Berikan feedback ke unit terkait • Resosialisasi regulasi Etika batuk/bersin • Buat ICRA Etika Batuk /bersin • Edukasi etika batuk/bersin ke pasien, pengunjung dan masyarakat.
		Monitoring penempatan pasien dan kewaspadaan transmisi.	• Revisi Regulasi Kewaspadaan Transmisi dan penempatan pasien. • Sosialisasi regulasi dan SPO Penempatan pasien. • Audit fasilitas kewaspadaan transmisi dan penempatan pasien. • Audit kepatuhan kewaspadaan transmisi dan penempatan pasien. • Rekap kepatuhan kewaspadaan transmisi dan penempatan pasien. • Berikan feedback ke unit terkait. • Usulan kelengkapan kewaspadaan transmisi dan penempatan pasien.

			• Buat ICRA Kewaspadaan transmisi dan penempatan pasien.
		Monitoring berfungsinya ruang isolasi rumah sakit dan penempatan pasien (airborne & immunocompromised) serta proses transfer pasiennya.	• Melakukan koordinasi dengan Kepala ruang dalam mengontrol ruang isolasi • Menyusun jadwal • Melakukan monitoring (oleh IPCN/IPCLN) • Menganalisa hasil monitoring • Membuat rencana tindak lanjut • Membuat laporan
		Monitoring Kepatuhan Penggunaan APD dan ketersediaan APD.	• Menyusun jadwal • Melakukan monitoring (oleh IPCN/IPCLN) • Menganalisa hasil monitoring • Membuat rencana tindak lanjut • Membuat laporan • Revisi SPO/panduan penggunaan APD. • Pelatihan dan sosialisasi panduan/SPO penggunaan APD. • Audit kepatuhan penggunaan APD. • Rekap hasil audit kepatuhan APD. • Berikan feedback ke unit terkait. • Audit fasilitas/ketersediaan APD di unit. • Edukasi penggunaan APD yang tepat antar sesama staf.
		Monitoring proses pelaksanaan Teknik aseptik.	• Optimalisasi Area Bersih tempat pencampuran obat di ruangan. • Buat usulan dispensing obat menggunakan Laminary Air Flow di Farmasi. • Monitoring Teknik aseptik pada proses perawatan pasien seperti perawatan luka, prosedur bedah, dll.
		Monitoring praktek penyuntikan yang aman dan pencegahan cedera karena benda tajam serta perlindungan karyawan.	• Revisi regulasi tentang penyuntikan yang aman. • Sosialisasi regulasi. • Audit kepatuhan penyuntikan yang aman. • Rekap hasil audit kepatuhan. • Berikan feed back kepada unit terkait.

			• Buat usulan fasilitas penyuntikan yang aman. • Buat ICRA Penyuntikan yang aman. • Revisi regulasi tentang kesehatan petugas. • Sosialisasi regulasi kesehatan petugas. • Koordinasi dengan Tim K3RS melaksanakan Medikal Cek Up karyawan baru dan seluruh karyawan sesuai prioritas. • Melaksanakan koordinasi pemeriksaan kesehatan karyawan baru Komite PPI Tim K3RS-Ka. Bid.Keu-Ka. Bid. Yan. • Konseling sesuai hasil Medikal Cek Up. • Melaksanakan Profilaksis pasca pajanan. • Membuat laporan rekapitulasi Pasca pajanan (tertusuk jarum/benda tajam, terpajan darah /cairan tubuh infeksius lainnya). • Resosialisasi regulasi alur penanganan dan pelaporan pajanan. • Buat ICRA Perlindungan petugas
		Monioring kebersihan lingkungan	• Menyusun jadwal • Melakukan monitoring (oleh IPCN/IPCLN) • Menganalisa hasil monitoring • Membuat rencana tindak lanjut • Membuat laporan
		Monitoring manajemen linen	• Koordinasi dengan bagian laundry untuk monitoring mutu sesuai standar untuk linen kotor dan linen bersih • Melakukan Monitoring (oleh IPCN) • Menganalisa hasil monitoring • Membuat rencana tindak lanjut • Membuat laporan
		Monitoring pembuangan sampah infeksius, cairan tubuh, darah, dan benda tajam.	• Menyusun jadwal • Melakukan Monitoring (oleh IPCN/IPCLN) • Menganalisa hasil monitoring

			• Membuat rencana tindak lanjut • Membuat laporan
		Monitoring kegiatan sterilisasi di rumah sakit termasuk peralatan single use yang di re-use.	• Menyusun jadwal • Melakukan Monitoring (oleh IPCN/IPCLN) • Menganalisa hasil monitoring • Membuat rencana tindak lanjut • Membuat laporan
		Monitoring kegiatan pelayanan makanan	• Koordinasi dengan bagian gizi dalam mengontrol mutu makanan • Menyusun jadwal • Melakukan Monitoring (oleh IPCN) • Menganalisa hasil monitoring • Membuat rencana tindak lanjut • Membuat laporan
		Monitoring kegiatan permesinan	• Koordinasi dengan bagian pemeliharaan sarana untuk mengontrol permesinan di rumah sakit
		Monitoring pembongkaran, pembangunan dan renovasi	• Koordinasi dengan bagian pemeliharaan sarana rumah sakit dalam perencanaan pembangunan • Koordinasi dengan bagian pemeliharaan sarana rumah sakit dan pemborong pekerjaan pemeliharaan, pembangunan atau renovasi rumah sakit • Menyusun jadwal • Melakukan monitoring • Membuat rencana tindak lanjut • Membuat laporan
4	PPRA	Monitoring penggunaan antimikroba secara aman.	• Menyusun jadwal • Melakukan Monitoring (oleh IPCN/IPCLN) • Menganalisa hasil monitoring • Membuat rencana tindak lanjut • Membuat laporan

5	Pencegahan HAIs	Monitoring penerapan bundles HAIs	• Menyusun jadwal • Melakukan Monitoring (oleh IPCN/IPCLN) • Menganalisa hasil monitoring • Membuat rencana tindak lanjut • Membuat laporan • Audit kepatuhan Bundles HAIs
		Melakukan investigasi outbreak	• Mengumpulkan data • Melakukan analisa • Membuat rencana tindak lanjut • Melakukan tindakan perbaikan
6	Edukasi dan Pelatihan	Diklat internal tentang PPI / sosialisasi PPI	Bekerja sama dengan bagian Diklat rumah sakit dalam: • Melakukan diklat internal pada karyawan Rumah Sakit • Sosialisasi PPI pada karyawan baru • Menganalisa hasil kegiatan diklat • Membuat rencana tindak lanjut • Membuat laporan
		Pelatihan PPI dasar untuk anggota komite, Tim PPI dan seluruh karyawan rumah sakit	• Menyusun jadwal pelatihan • Membuat laporan
		Edukasi dan sosialisasi terkait PPI: - Edukasi individu - Edukasi kelompok - Edukasi elektronik	• Melakukan edukasi/penyuluhan individu pada sesama staf, pasien dan pengunjung. • Melakukan edukasi/penyuluhan pada kelompok pasien/pengunjung RS, berkoordinasi dengan tim PKRS setiap 1 minggu sekali (4x dalam 1 bulan). • Melakukan edukasi/penyuluhan pada media elektronik dengan menampilkan video khusus terkait PPI berkoordinasi dengan tim PKRS.
		Orientasi Umum Staf baru	• Kegiatan orientasi pada anggota Komite PPI baru dilakukan oleh IPCN. • Materi orientasi untuk staf baru mewajibkan pengenalan PPI Dasar pada seluruh staf baru berkoordinasi dengan bagian SDM. • Materi PPI dasar meliputi kewaspadaan Isolasi (kewaspadaan standar & transmisi).

6	Rapat	Rapat koordinasi antar Komite	• Laporan infeksi terkait HAI's • Melaporkan hasil surveilans • Kendala & masalah antar komite • Rencana tindak lanjut
		Rapat koordinasi dengan manajemen rumah sakit	• Laporan infeksi terkait HAI's • Melaporkan kegiatan PPI • Kendala & masalah PPI • Rencana tindak lanjut
		Rapat bulanan Komite PPI	• Laporan infeksi terkait HAI's • Melaporkan kegiatan PPI • Kendala & masalah PPI • Rencana tindak lanjut
7	Pengembangan Pelayanan	"PPI Quick Tips"	Program training singkat 1-2 menit yang diberikan setiap hari/setiap shift kepada staf (Perawat, nakes lain, CS, dll) focus pada 1 materi kecil terkait PPI. Tujuan: • Edukasi PPI tidak membosankan • Materi mudah diingat karena pendek • Konsisten PPI meningkat tanpa perlu pelatihan formal Panjang. Sasaran: Perawat, petugas CS, Bidan/dokter jaga, Petugas lab/radiologi, gizi, dll Cara Pelaksanaan: 1. Dipimpin oleh PIC PPI unit/Karu/PJ shift. 2. Dilakukan saat: serah terima shift, briefing CS, morning briefing, dll 3. PIC menyampaikan 1 materi singkat (30-60 detik) 4. Praktik cepat (jika perlu) – 20 detik 5. PIC mengisi logbook pelaksanaan.
8	Fasilitas Kesehatan dan K3	Pemeliharaan alat	Set Komputer: • Pembersihan permukaan set computer dilakukan setiap hari oleh petugas IPCN yang berdinis.

			• Update software berkoordinasi dengan bagian IT RS. - Komite PPI memberikan saran/masukan terkait pemeliharaan alat kepada unit: • Pemeriksaan swab alat steril dilakukan rutin 6 bulan sekali.			
		Kesehatan staf	• Program pemenuhan gizi seimbang dengan jumat berkah dan pemberian nutrisi tambahan pada unit khusus. • Pemberian asupan vitamin pada seluruh karyawan minimal 1 bulan sekali. • Pemeriksaan kesehatan karyawan rutin 1 tahun sekali. • Pemeriksaan kesehatan karyawan di unit khusus rutin berkala.			
9	Manajemen Resiko	Resiko HAI's (Keselamatan Pasien): Infeksi Aliran Darah Perifer (Phlebitis), Infeksi daerah operasi (IDO), Infeksi saluran kencing (ISK), VAP, IADP, Decubitus	Melakukan upaya pencegahan: • Melakukan Bundles Phlebitis • Melakukan Bundles IDO • Melakukan Bundles ISK • Melakukan Bundles VAP • Melakukan Bundles IADP • Melakukan pencegahan decubitus			
		Pajanan infeksius (Keselamatan Staf)	Melakukan upaya pencegahan: 1. Tidak melakukan recapping jarum 2. Menggunakan APD sesuai indikasi 3. Cuci tangan 6 langkah 5 moment 4. Jaga jarak aman 5. Melaporkan kejadian pajanan			
10	Mutu PPI	Usulan judul Mutu PPI 2026	No	Pengukuran Mutu	Standart	
			1	Angka infeksi aliran darah perifer (Phlebitis)	≤5%	
			2	Angka infeksi saluran kencing (ISK)	≤4,7‰	
			3	Angka Pneumonia akibat penggunaan ventilator (VAP)	≤5,8‰	
			4	Angka infeksi daerah operasi (IDO)	≤2%	
			5	Angka infeksi aliran darah primer (IADP)	≤3,5‰	
			6	Angka decubitus	0%	

			7	Angka kepatuhan kebersihan tangan	>85%
			8	Angka kepatuhan penggunaan APD oleh petugas	100%
			9	Kepatuhan pemantauan dan pencatatan suhu & kelembapan ruang serta tempat penyimpanan.	100%
			10	Kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan)	0

Tabel 3.1.1 Lampiran data jumlah SDM Komite PPI RS Prima Husada

Jabatan	Jumlah SDM Komite PPI			Keterangan
	Standar	2025	Kebutuhan	
IPCO	1	1	0	
IPCN	1	1	0	1 purna waktu
IPCLN	17	17	0	IPCLN merangkap kegiatan pelayanan pasien
Maternitas	1	1	0	
Gizi	1	1	0	
IPSRS & K3RS	1	1	0	
CSSD	1	1	0	
Laundry	1	1	0	
Cleaning Service	1	1	0	
Petugas Kamar Jenazah	1	1	0	
Laboratorium	1	1	0	
IFRS	1	2	0	1 Gudang Farmasi, 1 Pelayanan Farmasi
Instalasi Rekam Medis	1	1	0	
Asuransi Center	1	1	0	
Radiologi	1	1	0	

3.2 Sasaran

- 1. Semua staf di area rumah sakit termasuk dalam program pencegahan dan pengendalian infeksi termasuk pula semua orang yang berada dan melakukan aktifitas di rumah sakit yaitu tenaga kesehatan (medis dan non medis), tenaga non kesehatan (house keeping, satpam, tukang parkir, kantin dan lain-lain), pasien, keluarga pasien dan pengunjung.
- 2. Semua area di rumah sakit termasuk dalam program pencegahan dan pengendalian infeksi yaitu area pelayanan pasien (rawat inap, rawat jalan, Laboratorium, CSSD, Laundry, Gizi, Farmasi, kamar jenazah dll) dan non pelayanan pasien (Rekam medik, sanitasi, keuangan, kepegawaian dll) serta fasilitas umum (ruang tunggu, parkir, kantin dll).
- 3. Rincian sasaran kegiatan:

No	RINCIAN KEGIATAN POKOK	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET / STANDAR	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
1	Menentukan kebutuhan SDM Komite PPI	Memastikan SDM Komite PPI mencukupi sesuai standar PMK agar program PPI berjalan efektif	• SDM Komite PPI (Ketua, IPCN, IPCLN, anggota komite lainnya) • Unit kerja yang membutuhkan pendampingan PPI	SK	• Kesesuaian SDM Komite PPI dengan PMK 27 tahun 2017 (1 IPCN per 100 TT) • SOTK komite PPI terpenuhi	• Tersusunnya SK komite PPI lengkap. • Minimal 90% unit memiliki IPCLN yang aktif terutama area perawatan.	-
2	Melakukan surveillans HAI's dan mutu PPI	Evaluasi mutu terkait infeksi di rumah sakit.	• Angka IDO • Angka IADP • Angka VAP • Angka ISK • Angka Phlebitis • Angka Decubitus	Data	• ≤2% • ≤3,5‰ • ≤5,8‰ • ≤4,7‰ • ≤5% • 0%	Tercapainya target/standar pada laporan setiap bulannya.	-
2	Melakukan investigasi dan analisis risiko infeksi dengan	Mengidentifikasi dan mencegah kejadian infeksi	• Insiden infeksi HAI's	Data	• Tidak ada laporan	• Tercapainya target tidak ditemukan kejadian	-

No	RINCIAN KEGIATAN POKOK	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET / STANDAR	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	program mutu, keselamatan pasien dan keselamatan kerja (Manrisk)	melalui investigasi dan analisis risiko yang terintegrasi dengan Mutu PMKP dan K3.	- Paparan petugas - Area beresiko infeksi		kejadian risiko infeksi yang menjadi actual.	infeksi pada laporan bulanan. Insiden berisiko infeksi diinvestigasi dan dianalisis 100%. (jika ditemukan)	
3	Membuat <i>Infection Risk Assesment</i> (ICRA)	Mengidentifikasi resiko infeksi yang ada di unit dan rumah sakit, serta mengetahui grading, untuk dilakukan rencana tindak lanjut yang tepat untuk perbaikan mutu rumah sakit, terutama pada area yang beresiko.	All unit	Data	Tidak ada laporan kejadian risiko infeksi yang menjadi actual.	Tercapainya target pada Laporan bulanan IPCN, Laporan Komite PPI	-
4	Monitoring kepatuhan Hand hygiene dan fasilitas kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan staf dan pengunjung rumah sakit.	All unit	Data	>85%	Tercapainya target pada Laporan bulanan IPCN, Laporan Komite PPI.	-
5	Monitoring penerapan etika batuk.	Mencegah penyebaran infeksi antara satu dengan lainnya.	All unit	Data	100%	Tercapainya target pada Laporan bulanan IPCN, Laporan Komite PPI.	-
6	Monitoring penempatan pasien dan kewaspadaan transmisi.	Mencegah penularan infeksi/pajanan antara pasien, petugas dan pasien lainnya.	Unit perawatan pasien	Data	100%	Tercapainya target pada Laporan bulanan IPCN, Laporan Komite PPI.	-

No	RINCIAN KEGIATAN POKOK	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET / STANDAR	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
7	Monitoring berfungsinya ruang isolasi rumah sakit dan penempatan pasien (airborne & immunocompromised) serta proses transfer pasiennya.	Mencegah penularan infeksi/pajanan antara pasien, petugas dan pasien lainnya.	Ruang Isolasi	Data	100%	Tercapainya target pada Laporan bulanan IPCN, Laporan Komite PPI.	-
8	Monitoring Kepatuhan Penggunaan APD dan ketersediaan APD.	Mencegah penularan infeksi/pajanan antara pasien, petugas dan pasien lainnya.	All unit	Data	100%	Tercapainya target pada Laporan bulanan IPCN, Laporan Komite PPI.	-
9	Monitoring proses pelaksanaan Teknik aseptik.	Mencegah terjadinya infeksi HAIs.	All unit pelayanan pasien	Data	100%	Tercapainya target pada Laporan bulanan IPCN, Laporan Komite PPI.	-
10	Monitoring praktek penyuntikan yang aman dan pencegahan cedera karena benda tajam serta perlindungan karyawan.	Mencegah penularan infeksi/pajanan antara pasien, petugas dan pasien lainnya.	- All unit pelayanan pasien - MCU Karyawan	Data	100%	Tercapainya target pada Laporan bulanan IPCN, Laporan Komite PPI.	-
11	Monitoring kebersihan lingkungan	Menjaga lingkungan tetap bersih dan rapi supaya terhindar dari penyebaran kuman penyakit.	- All unit - Swab lingkungan - Uji air bersih - Uji air minum	Data	100% Hasil swab lingkungan & uji air baik.	Tercapainya target pada Laporan bulanan IPCN, Laporan Komite PPI, Hasil swab lingkungan & uji air.	PMK No.2 Tahun 2023
12	Monitoring manajemen linen	Mencegah penyebaran kuman penyakit melalui manajemen linen yang baik.	- Laundry - CSSD - Unit pelayanan pasien - Swab linen	Data	100%	Tercapainya target pada Laporan bulanan IPCN, Laporan Komite PPI, hasil swab linen baik.	PMK No.2 Tahun 2023

No	RINCIAN KEGIATAN POKOK	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET / STANDAR	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
13	Monitoring pembuangan sampah infeksius, cairan tubuh, darah, dan benda tajam.	Mencegah penularan infeksi/pajanan antara pasien, petugas dan pasien lainnya.	- All unit pelayanan pasien - Uji air limbah	Data	100%	Tercapainya target pada Laporan bulanan IPCN, Laporan Komite PPI, hasil uji air limbah.	PMK No.2 Tahun 2023
14	Monitoring kegiatan sterilisasi di rumah sakit termasuk peralatan single use yang di re-use.	Mencegah penyebaran kuman penyakit melalui manajemen sterilisasi yang baik.	- CSSD - Unit pelayanan pasien - Swab alat medis & re-use	Data	100%	Tercapainya target pada Laporan bulanan IPCN, Laporan Komite PPI, hasil swab alat baik.	PMK No.2 Tahun 2023
15	Monitoring kegiatan pelayanan makanan	Mencegah penyebaran kuman penyakit melalui manajemen pelayanan makanan yang baik.	- Instalasi gizi - All unit pelayanan pasien - Uji bahan makanan. - Swab alat makan & dapur. - Rectal swab penjamah makanan	Data	100%	Tercapainya target pada Laporan bulanan IPCN, Laporan Komite PPI, hasil swab dan uji hygiene dapur baik.	PMK No.2 Tahun 2023
16	Monitoring kegiatan permesinan	Mengontrol ketepatan suhu dan kelembapan udara untuk mencegah koloni kuman penyakit.	All unit	Data	100%	Tercapainya target pada Laporan bulanan IPCN, Laporan Komite PPI.	-

No	RINCIAN KEGIATAN POKOK	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET / STANDAR	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
17	Monitoring pembongkaran, pembangunan dan renovasi	Mencegah infeksi akibat proses renovasi atau Pembangunan.	Kegiatan renovasi/pembangunan	ICRA	100%	Proses ICRA bangunan berjalan dengan baik, beserta PCRA nya.	-
18	Monitoring penggunaan antimikroba secara aman.	Mencegah penggunaan antibiotic lebih dari 1 untuk mencegah resistensi terhadap kuman.	- Pasien yang mendapat antibiotic. - PPRA	Peta kuman	Penggunaan antibiotic tepat. Hasil kultur baik.	Tercapainya target/standar.	-
19	Monitoring penerapan bundles HAIs.	Mencegah terjadinya infeksi HAIs pada proses perawatan pasien.	- Bundle IDO - Bundle IADP - Bundle VAP - Bundle ISK - Bundle phlebitis - Bundle decubitus	Data	100%	Tercapainya target pada Laporan bulanan IPCN, Laporan Komite PPI.	-
20	Melakukan investigasi outbreak.	Melakukan tindak lanjut sebagai Upaya pencegahan supaya tidak timbul outbreak baru.	Kejadian luar biasa	Data	Kejadian = 0	Laporan outbreak / KLB	-
21	Diklat internal tentang PPI / sosialisasi PPI.	Menambah informasi dan pengetahuan petugas terkait pencegahan infeksi.	- Diklat PPI Dasar All petugas - Diklat CSSD unit perawatan.	TUMA NDOK	100% dihadiri oleh petugas.	Laporan hasil evaluasi diklat.	-
22	Edukasi dan sosialisasi terkait PPI: - Edukasi individu - Edukasi kelompok	Menambah informasi dan pengetahuan petugas, pasien, dan pengunjung terkait pencegahan infeksi.	- Petugas - Pasien - Pengunjung	Dokumentasi	100% dilakukan.	Tercapainya target pada Laporan bulanan IPCN, Laporan Komite PPI.	-

No	RINCIAN KEGIATAN POKOK	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET / STANDAR	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	- Edukasi elektronik						
22	Rapat PPI	Mengintegrasikan dan melaporkan hasil temuan dari PPI untuk didiskusikan dan mencari rencana tindak lanjut Bersama.	• Anggota Komite PPI • Manajerial • Komite RS lainnya	UMAN DOK	100% dilakukan.	UMANDOK rapat.	-
23	"PPI Quick Tips"	• Edukasi PPI tidak membosankan • Materi mudah diingat karena pendek • Konsisten PPI meningkat tanpa perlu pelatihan formal Panjang.	• Perawat, petugas CS, Bidan/dokter jaga, Petugas lab/radiologi, gizi, dll	Data (Logbook)	• Pelaksanaan >5 kali per bulan. • Semua unit melaksanakan. • Peningkatan kepatuhan PPI minimal 10%.	• Jumlah minimal sesi tercapai dalam 1 bulan. • Terdokumentasi dengan baik (logbook). • Tidak ada insiden infeksi yang terjadi/berulang.	-
24	Pemeliharaan alat di komite PPI	Memastikan seluruh sarana dan alat pendukung PPI berfungsi baik.	• Set komputer	Monitoring	>95% alat komite PPI dalam kondisi baik setiap bulannya.	• Presentase alat berfungsi baik. • Waktu respon perbaikan alat baik. • Tidak ada laporan keterlambatan layanan.	-

No	RINCIAN KEGIATAN POKOK	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET / STANDAR	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
25	Pemeriksaan kesehatan staf	Mengetahui kondisi kesehatan tenaga kesehatan agar aman bekerja dan tidak menjadi sumber penularan infeksi.	Seluruh staf di rumah sakit	MCU	>95% tenaga kesehatan menjalani pemeriksaan kesehatan tahunan. 100% staf baru dilakukan MCU. 100% staf terpapar cairan tubuh dilakukan pemeriksaan post exposure dalam <24 jam.	- Laporan hasil MCU staf. - Prosentase staf risiko tinggi berkurang karena telah diskriming. - Tidak ada kejadian penularan infeksi dari staf ke pasien.	-
26	Upaya pencegahan manajemen resiko keselamatan pasien dan staf berhubungan dengan kejadian Infeksi.	Mencegah terjadinya kejadian infeksi yang membahayakan pasien dan staf.	All unit	Data	- Tidak ada kejadian infeksi baik pada pasien maupun staf. 100% kejadian paparan	- Tidak ada laporan kejadian infeksi. - Penurunan tren kejadian risiko infeksi. - Kecepatan respon kejadian infeksi.	-

No	RINCIAN KEGIATAN POKOK	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET / STANDAR	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
					infeksi ditindaklanjuti <24 jam.		

3.3 Cara Melaksanakan Kegiatan

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
1	Menentukan kebutuhan SDM Komite PPI	- Melakukan pemetaan jumlah unit kerja & beban kerja PPI - Menghitung kebutuhan SDM berdasarkan PMK 27/2017 (1 IPCN/100 TT) - Mengidentifikasi kompetensi SDM yang dibutuhkan - Melakukan koordinasi dengan bagian SDM & direksi - Menyusun usulan kebutuhan SDM Komite PPI	Observasi Wawancara Review dokumen	Form pemetaan SDM PPI Data TT & jumlah unit Struktur organisasi PMK 27/2017	Triwulan atau sesuai kebutuhan	- Usulan SK Komite PPI	-
2	Surveilans	- Tetapkan kamus indikator pengambilan data surveilans. - Lakukan sensus harian di SIMRS. - Tarik data pada SIMRS. - Lakukan Analisa. - Buat rencana tindak lanjut. - Laporkan pada laporan rutin.	Sensus	SIMRS	Setiap hari pukul 08.00 – 14.00	- Hasil data pada SIMRS - Laporan Bulanan IPCN - Laporan Triwulan Komite PPI - Laporan Tahunan Komite PPI	-

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
		- Lakukan monitoring.					
3	Audit bundles HAIs	- Susun format audit. - Lakukan sensus harian. - Lakukan penghitungan hasil audit. - Analisa hasil monitoring. - Buat rencana tindak lanjut. - Buat laporan rutin. - Lakukan monitoring.	Sensus	Google Spreadsheet Form Audit Bundles HAIs	Setiap hari (3 shift pelayanan)	- Hasil rekap data audit bundles HAIs di google spreadsheet - Laporan Bulanan IPCN - Laporan Triwulan Komite PPI - Laporan Tahunan Komite PPI	-
4	Audit supervise / monitoring kewaspadaan isolasi.	- Tentukan jadwal audit supervisi. - Lakukan audit supervise ke unit-unit. - Berikan teguran langsung kepada petugas unit jika terdapat ketidaksesuaian. - Lakukan Analisa hasil audit. - Buat rencana tindak lanjut. - Buat laporan rutin.	Supervisi langsung	Google Spreadsheet Form Audit Supervisi IPCN	Minimal 2x /minggu	- Form Audit Supervisi IPCN - Laporan Bulanan IPCN - Laporan Triwulan Komite PPI - Laporan Tahunan Komite PPI	-
5	ICRA (Assesmen Resiko Infeksi)	- Identifikasi resiko infeksi. - Lakukan scoring dan grading. - Analisa resiko infeksi. - Evaluasi resiko infeksi. - Susun Langkah-langkah pencegahan dan pengendalian infeksi. - Monitoring pelaksanaan kebijakan, prosedur dan pedoman – pedoman PPI. - Pencatatan dan pelaporan insiden pajanan.	Identifikasi	Form ICRA program	Satu tahun sekali	- Form hasil data ICRA program - Manajemen risiko infeksi RS - Evaluasi pada laporan PPI	-

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
6	Investigasi outbreak	- Kumpulkan data. - Lakukan Analisa data. - Buat rencana tindak lanjut. - Lakukan Tindakan perbaikan.	Sensus	-	Jika ditemukan adanya outbreak/KLB	- Laporan outbreak / KLB	-
7	Diklat Internal PPI	- Buat TOR pelaksanaan diklat internal. - Lakukan update materi dan susun materi sesuai update. - Lakukan diklat rutin kepada seluruh karyawan. - Buat laporan evaluasi hasil diklat. - Dokumentasikan TUMANDOKnya.	Ceramah Diskusi Pitstop Simulasi Praktek langsung	Lembar balik, PPT, kartu permainan	Satu tahun sekali	- TOR - UMANDOK - Laporan evaluasi hasil diklat.	-
7	Rapat PPI	- Susun materi / permasalahan yang akan dibahas pada rapat. - Buat undangan rapat. - Dokumentasikan UMANDOKnya.	Ceramah Diskusi	Langsung/f orum rapat Zoom G-meet	Satu minggu sekali Satu bulan sekali Tiga bulan sekali	- UMANDOK rapat	-
8	"PPI Quick Tips"	- Dipimpin oleh PIC PPI unit/Karu/PJ shift. - Dilakukan saat: serah terima shift, briefing CS, morning briefing, dll - PIC menyampaikan 1 materi singkat (30-60 detik) - Praktik cepat (jika perlu) – 20 detik - PIC mengisi logbook pelaksanaan.	Ceramah Diskusi Praktek langsung	Kartu bergambar/ permainan	Setiap hari saat operan shift	- Logbook kegiatan	-

3.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2026

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Melakukan surveillans HAI's dan mutu PPI	• Angka IDO • Angka IADP • Angka VAP • Angka ISK • Angka Phlebitis • Angka Decubitus	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	SIMRS	IPCN IPCLN	-	-
2	Membuat <i>Infection Risk Assesment</i> (ICRA)	All unit											☑	☑	All unit	IPCN Karu	-	-
3	Monitoring kepatuhan Hand hygiene dan fasilitas kebersihan tangan.	All unit	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	All unit	IPCLN Karu IPCN	PT. DPM sesuai RBA	-
4	Monitoring penerapan etika batuk.	All unit	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	All unit	IPCLN Karu IPCN	-	-
5	Monitoring penempatan pasien dan kewaspadaan transmisi.	Unit perawatan pasien	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	Unit perawatan pasien	IPCLN Karu IPCN	-	-
6	Monitoring berfungsinya ruang isolasi rumah sakit dan penempatan pasien (airborne &	Petugas ruang Isolasi	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	Ruang Isolasi	IPCLN Karu IPCN	-	-

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	immunocompromised) serta proses transfer pasiennya.																	
7	Monitoring Kepatuhan Penggunaan APD dan ketersediaan APD.	All unit	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	All unit	IPCLN Karu IPCN	PT. DPM sesuai RBA	-
8	Monitoring proses pelaksanaan Teknik aseptik.	All unit pelayanan pasien	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	All unit pelayanan pasien	IPCLN Karu IPCN	-	-
9	Monitoring praktek penyuntikan yang aman dan pencegahan cedera karena benda tajam serta perlindungan karyawan.	• All unit pelayanan pasien	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	All unit pelayanan pasien	IPCLN Karu IPCN	-	-
		• MCU Karyawan							☑						Poli MCU	K3RS PPI SDM	PT. DPM sesuai RBA	-
10	Monitoring kebersihan lingkungan.	• All unit	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	All unit	IPCLN	-	-
		• Swab lingkungan dan uji udara ruangan						☑						☑	Sampling unit	Karu IPCN Kesling	PT. DPM sesuai RBA	-
		• Uji ambient udara								☑					Area RS		PT. DPM sesuai RBA	-
		• Uji air bersih & minum (fisika, biologi)	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	Sumur bor, sumber air galon		PT. DPM sesuai RBA	-

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			PT. DPM sesuai RBA	
		• Uji air bersih & minum (kimia)				☑						☑						-
11	Monitoring manajemen linen.	• Laundry • CSSD • Unit pelayanan pasien	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	Laundry, unit pelayanan.	Karu IPCN	-	-
		• Swab linen						☑						☑	CSSD	Kesling, IPCN	PT. DPM sesuai RBA	-
12	Monitoring pembuangan sampah infeksius, cairan tubuh, darah, dan benda tajam.	• All unit pelayanan pasien	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	All unit, TPS B3, IPAL	IPCLN, Karu, IPCN, Kesling	-	-
		• Uji air limbah	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	Outlet IPAL	Kesling, IPCN	PT. DPM sesuai RBA	-
13	Monitoring kegiatan sterilisasi di rumah sakit termasuk peralatan single use yang di re-use.	• CSSD • Unit pelayanan pasien	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	CSSD, Unit pelayanan	Karu, IPCN	-	-
		• Swab alat medis & re-use (jika ada)						☑						☑	CSSD		PT. DPM sesuai RBA	-
14	Monitoring kegiatan pelayanan makanan.	• Instalasi gizi • All unit pelayanan pasien	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	Instalasi gizi	Karu, IPCN, Kesling	-	-
		• Uji bahan makanan.						☑						☑			PT. DPM sesuai	-

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			RBA	
																	PT. DPM sesuai RBA	
		Swab alat makan & dapur.						☑						☑				-
		Rectal swab penjamah makanan	☑						☑						Laboratorium		PT. DPM sesuai RBA	-
15	Monitoring kegiatan permesinan.	All unit	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	All unit	IPSRS, Kesling, IPCN	-	-
16	Monitoring pembongkaran, pembangunan dan renovasi.	Kegiatan renovasi/pembangunan	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	Area renovasi	IPSRS, Kesling, IPCN	-	-
17	Monitoring penggunaan antimikroba secara aman.	Pasien yang mendapat antibiotic.	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	Unit perawatan	Apoteker, Dokter, Perawat /bidan, IPCN	-	-
		PPRA (Peta Kuman)												☑	Lab	IPCN, PPRA	PT. DPM sesuai RBA	-
18	Monitoring penerapan bundles HAIs.	- Bundle IDO - Bundle IADP - Bundle VAP	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	Unit perawatan	IPCLN, Karu, IPCN	-	-

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		• Bundle ISK • Bundle phlebitis • Bundle decubitus																
19	Melakukan investigasi outbreak.	Kejadian luar biasa	Jika terjadi outbreak/KLB												RS	K3RS, IPCN	-	-
20	Diklat internal tentang PPI.	• Diklat PPI Dasar All petugas					☑								Hall Sakura	IPCN	PT. DPM sesuai RBA	-
		• Diklat CSSD unit perawatan				☑									Hall Cemara	Karu CSSD, IPCN	PT. DPM sesuai RBA	-
21	Edukasi dan sosialisasi terkait PPI seperti hand hygiene dan etika batuk.	• Petugas • Pasien • Pengunjung	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	Ruang tunggu pelayanan	IPCLN, IPCN	PT. DPM sesuai RBA	-
22	Rapat PPI	• Anggota Komite PPI • Manajerial	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	Hall/ online	IPCN	PT. DPM sesuai RBA	-
		• Triwulan Komite RS lainnya	☑			☑			☑			☑			Hall/ online	Sekretariat	PT. DPM sesuai RBA	-
23	“PPI Quick Tips”	• Petugas	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	All unit	Karu, IPCLN/ PJ shift, IPCN	-	-

3.5 Kebutuhan Anggaran

Anggaran biaya berdasarkan rata-rata pemakaian:

NO	Kegiatan	BAHAN	RATA /BULAN	KEBUTUHAN 1 TAHUN		HARGA SATUAN	TOTAL	KET
1	Hand hygiene	Handrub	30	360	Botol (500 ml)	Rp. 65.000,00	Rp. 23.400.000,00	-
		Bracket handrub	4	50	pcs	Rp. 30.000,00	Rp. 1.500.000,00	-
		Botol pump	5	60	pcs	Rp. 8.000,00	Rp. 480.000,00	-
		Sabun cuci tangan	6 galon (5 L)	72	Galon 5 L	Rp. 360.000,00	Rp. 25.920.000,00	-
		Tissue handtowel	83	1000	pack	Rp. 15.000,00	Rp. 15.000.000,00	-
		Dispenser tissue	1	12	pcs	Rp. 120.000,00	Rp. 1.440.000,00	-
		Stiker HH	10	150	pcs	Rp. 5000,00	Rp. 750.000,00	-
2	Etika Batuk	Poster Etika batuk	1	12	pcs	Rp. 10.000,00	Rp. 120.000,00	Koord. PKRS
3	Penempatan pasien & monitoring permesinan	Thermohygro	4	55	pcs	Rp. 65.000,00	Rp. 3.575.000,00	Koord. IPSRS
4	APD	Sarung tangan bersih (XS, S, M, L)	5.811	69.732	pcs	Rp. 750,00	Rp. 52.299.000,00	-
		Sarung tangan steril	1.261	1.532	pcs	Rp. 10.000,00	Rp.15.320.000,00	-
		Sarung tangan kerja	20	240	pasang	Rp. 50.000,00	Rp. 12.000.000,00	-
		Masker bedah	3.394	40.728	pcs	Rp. 320,00	Rp. 13.032.960,00	-
		Masker N95	30	360	pcs	Rp. 29.500,00	Rp.10.620.000,00	-
		Face shield	1	5	pcs	Rp. 125.000,00	Rp. 625.000,00	-
		Goggles	1	12	pcs	Rp. 65.000,00	Rp. 780.000,00	-
		Apron disposable	1	12	pcs	Rp. 27.000,00	Rp. 324.000,00	-
		Apron re-useable (dapur, laundry, OK, CSSD)	360	4.320	pcs	Rp. 3.500,00	Rp. 15.120.000,00	-
		Sepatu boot	1	12	pasang	Rp. 100.000,00	Rp. 1.200.000,00	-

NO	Kegiatan	BAHAN	RATA /BULAN	KEBUTUHAN 1 TAHUN		HARGA SATUAN	TOTAL	KET
5	Penanganan tumpahan (Spill kit) dan Dekontaminasi	Box spill kit	1	6	pcs	Rp. 50.000,00	Rp. 300.000,00	-
		Sumpit	2	24	pcs	Rp.1.000,00	Rp. 24.000,00	-
		Klorin	48 L	576	L	Rp. 19.500,00	Rp. 11.232.000,00	-
		Kain Lap / kanebo	25	150	pcs	Rp. 8.000,00	Rp. 1.200.000,00	-
		Sapu/sekop pengki	1	12	pcs	Rp. 10.000,00	Rp. 120.000,00	-
		Alcohol (70%)	48	576	pcs	Rp. 80.000,00	Rp. 46.080.000,00	-
		Betadine	2	24	botol	Rp. 100.000,00	Rp. 2.400.000,00	-
		Desinfektan IKO	4	48	botol	Rp. 165.000,00	Rp. 7.920.000,00	-
		Kantong kresek coklat	5	50	pcs	Rp. 200,00	Rp. 10.000,00	Koord. IPSRS
6	Penanganan limbah	Tempat sampah pijakan	2	24	Pcs (25 L)	Rp. 115.000,00	Rp. 2.760.000,00	Koord. CS
		Kantong kresek kuning	1.550	18.600	pcs	Rp. 1.800,00	Rp. 33.480.000,00	Koord. CS
		Kantong kresek hitam	3.000	36.000	pcs	Rp. 1.500,00	Rp. 54.000.000,00	Koord. CS
		Safety box kuning	120	1440	Pcs (12,5L)	Rp. 30.000,00	Rp. 43.200.000,00	Koord. CS
7	MCU Karyawan	BMHP & pemeriksaan	1x / tahun	1	kali	Rp. 35.000.000,00	Rp. 35.000.000,00	Koord. K3RS
8	Monitoring kebersihan Lingkungan	Swab lantai	1 kali pemeriksaan / 6 bulan pada	20	Pemeriksaan	Rp. 100.000,00	Rp. 2.000.000,00	Koord. Kesling/IPSRS
		Swab dinding	1 kali pemeriksaan / 6 bulan pada	20	Pemeriksaan	Rp. 100.000,00	Rp. 2.000.000,00	Koord. Kesling/IPSRS
		Uji air bersih (fisika)	1 kali pemeriksaan / bulan pada 2 titik	24	Pemeriksaan	Rp. 925.000,00	Rp. 22.200.000,00	Koord. Kesling/IPSRS
		Uji air bersih (biologi)	1 kali pemeriksaan / bulan pada 2 titik	24	Pemeriksaan	Rp. 925.000,00	Rp. 22.200.000,00	Koord. Kesling/IPSRS

NO	Kegiatan	BAHAN	RATA /BULAN	KEBUTUHAN 1 TAHUN		HARGA SATUAN	TOTAL	KET
		Uji air bersih (kimia)	1 kali pemeriksaan / 6 bulan	4	Pemeriksaan	Rp. 925.000,00	Rp. 3.700.000,00	Koord. Kesling/IPSRS
		Uji air minum (fisika)	1 kali pemeriksaan / bulan	12	Pemeriksaan	Rp. 1.335.000,00	Rp. 16.020.000,00	Koord. Kesling/IPSRS
		Uji air minum (biologi)	1 kali pemeriksaan / bulan	12	Pemeriksaan	Rp. 1.335.000,00	Rp. 16.020.000,00	Koord. Kesling/IPSRS
		Uji air minum (kimia)	1 kali pemeriksaan / 6 bulan	2	Pemeriksaan	Rp. 1.335.000,00	Rp. 2.670.000,00	Koord. Kesling/IPSRS
		Biaya transport	1 kali pemeriksaan / 6 bulan	5	Kali	Rp. 250.000,00	Rp. 1.250.000,00	Koord. Kesling/IPSRS
		Swab Meja IKO	1 kali pemeriksaan / 6 bulan pada 3 meja	6	Pemeriksaan	Rp. 100.000,00	Rp. 600.000,00	Koord. Kesling/IPSRS
		Uji Udara (dalam ruang)	1 kali pemeriksaan / 6 bulan pada 5 sampling ruang	10	Pemeriksaan	Rp. 85.000,00	Rp. 850.000,00	Koord. Kesling/IPSRS
		Uji ambient udara	1 kali pemeriksaan	1	Kali	Rp. 2.800.000,00	Rp. 2.800.000,00	Koord. Kesling/IPSRS
9	Monitoring Laundry	Swab linen	1 kali pemeriksaan / 6 bulan x 2 sample (skort IKO & duk IKO)	4	Pemeriksaan	Rp. 100.000,00	Rp. 300.000,00	Koord. Kesling/IPSRS
10	Monitoring limbah	Uji air limbah (fisika, biologi)	1 kali pemeriksaan / bulan	12	Kali pemeriksaan	Rp. 1.060.000,00	Rp. 12.720.000,00	Koord. Kesling/IPSRS
		Uji air limbah (kimia)	1 kali pemeriksaan / 6 bulan	2	Kali pemeriksaan	Rp. 1.060.000,00	Rp. 2.120.000,00	Koord. Kesling/IPSRS
11	Monitoring CSSD	Swab rutin alat medis	1 kali pemeriksaan / 6 bulan	2 (2 alat)	Kali pemeriksaan	Rp. 100.000,00	Rp. 200.000,00	Koord. Kesling/CSSD

NO	Kegiatan	BAHAN	RATA /BULAN	KEBUTUHAN 1 TAHUN		HARGA SATUAN	TOTAL	KET
		Swab alat re-use	1 kali pemeriksaan / 6 bulan	2 (2 alat)	Kali pemeriksaan rutin	Rp. 100.000,00	Rp. 200.000,00	Koord. Kesling/CSSD
		Swab alat re-use (masa expired alat)	1 kali pemeriksaan pada 2 alat	20	Pemeriksaan	Rp. 100.000,00	Rp. 2.000.000,00	Koord. Kesling/CSSD
12	Monitoring kegiatan makanan	Uji bahan makanan	1 kali pemeriksaan / 6 bulan pada 3 bahan makanan	6	Pemeriksaan	Rp. 100.000,00	Rp. 600.000,00	-
		Swab alat makan & dapur	1 kali pemeriksaan / 6 bulan pada 4 alat makan	8	Pemeriksaan	Rp. 100.000,00	Rp. 800.000,00	-
		Rectal swab penjamah makanan	1 kali pemeriksaan / 6 bulan pada 10 penjamah makanan	20	Pemeriksaan	Rp. 100.000,00	Rp. 2.000.000,00	Koord. K3RS
13	Monitoring pembongkaran	Kertas HVS	1	1	rim	Rp. 44.000,00	Rp. 44.000,00	-
14	Monitoring penggunaan antimikroba	Peta kuman	1x / tahun	839	sampel	Rp. 378.000,00	Rp. 317.142.000,00	Koord. PPRA
16	Rapat PPI	Rapat bulanan PPI	1	12	Kali (online)	-	-	-
		Rapat Triwulan Komite	3 bulan sekali	4	Kali	Rp. 50.000,00	Rp. 200.000,00	-
		Rapat Koordinasi Unit	Min 1 kali	15	Kali	Rp. 30.000,00	Rp. 450.000,00	-
TOTAL							Rp. 862.317.960,00	-

Anggaran Kebutuhan Biaya Pengembangan SDM Komite PPI Tahun 2026

No	Kegiatan/Rincian Kegiatan	Internal/Eksternal	Jumlah (Satuan)	Harga Satuan	Total
1	Pelatihan IPCD	Eksternal	1 orang	Rp. 5.500.000,00	Rp. 5.500.000,00
2	Pelatihan IPCN lanjut/Resertifikasi IPCN	Eksternal	1 orang	Rp. 2.500.000,00	Rp. 2.500.000,00
3	Pelatihan PPI Dasar (IPCLN & Anggota Komite PPI Lainnya)	Eksternal	2 orang / tahun	Rp. 1.500.000,00	Rp. 3.000.000,00
4	In House Training (Seluruh Karyawan RS Prima Husada)	Internal	414 orang	Rp. 2.000,00	Rp. 828.000,00
5	Pelatihan CSSD (Unit pelayanan)	Internal	40 orang	Rp. 2.000,00	Rp. 80.000,00
6	Hadiah lomba kebersihan ruangan	Internal	3 x lomba/tahun	Rp. 1.000.000,00	Rp. 3.000.000,00
TOTAL					Rp. 14.908.000,00

Semua anggaran akan dibiayai dari anggaran Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah disetujui oleh PT Disa Prima Medika.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

8.1 Monitoring

Monitoring kegiatan dilaksanakan setiap waktu secara berjenjang mulai dari unit sendiri (IPCLN), kepala ruang, IPCN, dan seterusnya. Monitoring dilakukan secara rutin dan dilakukan pencatatan pada form monitoring yang nantinya akan dilaporkan kepada ketua Komite PPI dan Direksi. Pada saat monitoring dilakukan tindak lanjut secara langsung atas temuan yang dapat langsung dilakukan tindak lanjutnya.

8.2 Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan setiap akhir pelaksanaan kegiatan dan evaluasi program dilaksanakan pada akhir tahun.

Evaluasi dilakukan pula dalam bentuk rapat rutin yang dilakukan oleh Komite sebagai berikut:

- a. Rapat Komite PPI setiap 1 bulan sekali mengadakan rapat dengan seluruh anggota Komite PPI untuk menyampaikan hasil laporan dan bersama-sama menjalankan tindak lanjutnya.
- b. Rapat Koordinasi Antar Komite setiap 3 bulan sekali mengadakan rapat dengan Komite lainnya (PMKP, K3RS, Tim PKRS, PPRA, Komite Keperawatan dan Nakes lain) dan manajemen untuk menyampaikan hasil laporan dan bersama-sama menentukan tindak lanjutnya.
- c. Rapat Koordinasi Manajemen / antar unit isidentil dengan Karu dan manajemen untuk menyampaikan hasil laporan temuan untuk Bersama-sama menentukan tindak lanjutnya.

Dokumentasi kegiatan dilakukan pada saat akhir kegiatan dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan yang meliputi TOR, Laporan pelaksanaan, UMANDOK.

BAB V

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Upaya Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di RS Prima Husada tidak bisa diwujudkan hanya dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan saja, akan tetapi dibutuhkan upaya peningkatan sistem dan pemikiran yang holistik. Evaluasi kegiatan yang dilakukan dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dilakukan di semua unit kerja. Evaluasi kegiatan dilakukan sebagai berikut:

- a. Setiap 1 bulan IPCN membuat laporan pelaksanaan surveilans dan hasil audit supervisi dilaporkan ke Ka Komite PPI paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.
- b. Setiap 3 bulan Ka Komite PPI membuat analisa hasil surveilans dan hasil audit supervisi dilaporkan ke Direktur.
- c. Setiap 6 bulan Ka Komite PPI membuat Analisa hasil surveilans dan hasil audit supervise dilaporkan kepada Direktur.
- d. Laporan evaluasi tahunan pelaksanaan program disampaikan pada awal tahun berikutnya paling lambat tanggal 10 Januari.

Agar proses pelaksanaan program Pencegahan dan pengendalian Infeksi ini bisa berjalan sebagaimana mestinya, maka proses pelaksanaan kegiatan didokumentasikan dan dicatat setiap bulan oleh Komite PPI.

Seluruh pelaporan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi ini dilaporkan kepada Direktur. Direktur melaporkan hasil kegiatan program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi ke Kementrian Kesehatan RI dan Badan Kesehatan terkait lainnya.

BAB VI PENUTUP

Program kerja ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi RS Prima Husada Malang. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat meningkatkan mutu pelayanan RS Prima Husada Malang melalui Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.

Malang, 27 November 2025
Ketua Komite PPI



dr. Aida Musyarofah, Sp. OG

Disusun oleh,
IPCN/Sekretaris Komite PPI



Sherly Rosita, S. Kep. Ns

Mengetahui,
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah